



• GUIA PARA PROFISSIONAIS

Protocolos **Faciais** **passo a passo**

Limpeza de pele,
peelings,
**microagulhamento e
dermaplaning**

Com **checklist de
sessão** para
imprimir.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



PARTE 1 · ANTES DE PEGAR NO MATERIAL

01

Quem pode fazer e como descartar

Não existe uma lista única. Cada conselho tem suas normas e várias estão em disputa judicial. Este é o retrato das fontes abertas em **04/10/2026**. Confirme no seu conselho regional antes de incluir um procedimento no seu cardápio.

Profissão	O que as normas e decisões dizem hoje
Enfermagem Cofen 626/2020 e 715/2023	Enfermeiro esteta precisa de pós com 100h de prática e registro no Coren. Limpeza de pele está entre os procedimentos autorizados. Microagulhamento é vedado por sentença (proc. 20778-15.2017.4.01.3400). A Justiça Federal do DF suspendeu, em ação da SBD, a parte da Res. 529/2016 que permitia peelings químicos .
Biomedicina CFBM 197 e 200/2011	A Res. 200/2011 inclui peelings químicos e mecânicos na habilitação em estética. A Res. 241/2014, que listava procedimentos invasivos, foi anulada pelo TRF1 (decisão mantida em 03/2026, ação do CFM).
Fisioterapia COFFITO, Acórdão 293/2012	Na dermatofuncional, o peeling não pode ultrapassar o limite da epiderme . O acórdão não trata de microagulhamento: confirme a norma atual no Crefito.
Farmácia CFF 573/2013 e 669/2018	A 573/2013, que incluía peelings químicos e mecânicos, foi anulada (STF manteve em 10/2024). A 669/2018, sobre estética e responsabilidade técnica, foi mantida pelo TRF1 em 10/2025.
Esteticista Lei 13.643/2018	Executa procedimentos faciais com cosméticos, técnicas e equipamentos com registro na Anvisa . A lei exclui expressamente a estética médica.

1

Descarte de perfurocortantes

A RDC 222/2018 da Anvisa vale para salões e clínicas de estética. Agulhas, lancetas e lâminas vão para coletor rígido, com tampa e resistente à perfuração, trocado ao atingir **3/4 da capacidade**. É proibido esvaziar, reaproveitar, desconectar ou reencapar agulha com a mão.

2

Uso único é uso único

A RE 2605/2006 da Anvisa proíbe reprocessar agulhas com componentes plásticos não desmontáveis e bisturis descartáveis de lâmina fixa. Roller, ponteira de caneta e lâmina de dermaplaning se abrem na frente do cliente e vão para o descarte.

Por que tanta disputa? Na Lei do Ato Médico (12.842/2013), os incisos que definiam procedimento invasivo pela invasão da pele foram vetados. Cada conselho interpreta o vazio, e a Justiça decide caso a caso. A Anvisa abriu em 09/2026 a CP 1.423, que pode substituir a RE 2605/2006; até a norma final, a regra atual continua valendo.



Limpeza de pele, diamante e dermaplaning

As três agem na camada mais superficial da pele. A diferença está na ferramenta, no tempo de recuperação e no quanto de evidência existe por trás de cada uma.

Etapa	Limpeza de pele profunda: como fazer
1. Biossegurança	Jaleco, luvas, touca e máscara. Avaliação facial antes de tudo: tipo de pele, lesões, medicamentos.
2. Higienização	Remover maquiagem, sebo e impurezas com sabonete, gel ou loção adequados ao tipo de pele. Tônico para preparar.
3. Esfoliação	Física, química (AHA aplicado com pincel, sem esfregar) ou enzimática. Sem força em pele seca ou sensível.
4. Emoliência	Vapor, máscara térmica ou emoliente por cerca de 10 minutos, região por região, para amolecer os comedões.
5. Extração	Dedos envoltos em gaze ou algodão, com luvas, pressão em 2 pontos. Microagulha estéril só para milium ou comedão resistente (vai para o coletor). Não espremer lesão inflamada.
6. Finalização	Alta frequência (descongestionante e bactericida), máscara conforme o tipo de pele e fotoprotetor FPS acima de 30.
7. Home care	Limpeza suave uma vez ao dia, cremes sem óleo, fotoprotetor diário e não manipular lesões. Intervalo citado: a cada 28 dias , respeitando a renovação celular.

Contraindicações relativas da limpeza de pele: gestante e lactante, infecção na área, alergia aos produtos, dermatite, descamação intensa, pele queimada de sol, lesão sem diagnóstico, acne inflamatória e rosácea nodular. Acne grau III ou mais só com orientação médica.

Peeling de diamante

É a microdermoabrasão com ponteira diamantada e sucção. Remove a camada córnea, dura de 10 a 30 minutos e a intensidade vem do vácuo, da velocidade e do número de passadas. Os estudos usaram 6 sessões com 1 a 2 semanas de intervalo. É descrita como segura para todos os fototipos.

Dermaplaning

Lâmina estéril raspa a camada córnea e os pelos finos. Na histologia, pode tirar também parte da epiderme viva, o que aumenta a absorção do que vier depois. A evidência clínica é escassa. Evite em acne ativa, eczema e pele sensível.

Peelings químicos e microagulhamento

Nos dois casos, quanto mais fundo, maior o resultado e maior o risco. A classificação abaixo resume a diretriz da IADVL (2008) e duas revisões indexadas. Ela não autoriza ninguém: o limite de cada profissão está na Parte 1.

Peeling	Até onde chega	Agentes descritos na diretriz	Repetir
Muito superficial	Camada córnea	Glicólico 30–50%, salicílico 20–30%, TCA 10%, Jessner 1–3 camadas	1–2 sem.
Superficial	Toda a epiderme	Glicólico 50–70%, TCA 10–30%, Jessner 4–7 camadas	2–4 sem.
Médio	Derme reticular superior	TCA 35–50% ou combinações com TCA 35%	—
Profundo	Derme reticular média	Fenol (Baker-Gordon)	—

Antes e depois do peeling

Priming de 2 a 4 semanas com fotoprotetor e ativos leves de home care. Glicólico é neutralizado no tempo definido ou antes, se surgir branqueamento ou bolha. Depois: descamação de 1 a 3 dias no superficial, só hidratante neutro, FPS amplo e nada de arrancar pele.

Não faça se houver

Infecção ativa ou herpes, ferida aberta, dermatite em atividade, remédio fotossensibilizante, paciente que não vai se proteger do sol. Para médio e profundo, também quelóide e isotretinoína nos últimos 6 meses.

Microagulhamento	Agulha descrita	O que esperar
Uso cosmético facial	Até 0,5 mm	Praticamente indolor. Uma revisão de 2026 chama de "cosmético" o uso até 0,5 mm na face.
Rugas finas e textura	0,5 a 1,0 mm	Eritema leve e edema por 2 a 3 dias.
Cicatriz de acne	1,5 a 2,0 mm	Uso médico. Com 1,5 mm, pelo menos 3 semanas entre sessões.

Técnica descrita: anestésico tópico por 45 a 60 minutos, antisepsia, pele esticada e 5 passadas em cada direção (horizontal, vertical e oblíqua). O ponto final é o **sangramento puntiforme uniforme**. Sessões a cada 3 a 8 semanas; o colágeno continua se formando por 3 a 6 meses. Contraindicações: acne ativa, herpes ou outra infecção local, eczema ou psoríase, distúrbio de coagulação ou anticoagulante, tendência a quelóide, quimio ou radioterapia.

Profundidade é limite de quem faz. Não localizei norma da Anvisa que fixe milímetros por profissão. O limite vem da indicação no registro do equipamento e das normas e sentenças da Parte 1. A Anvisa também alertou que produto aplicado por microagulhamento **não pode ser regularizado como cosmético**.



Fototipo, cronograma e checklist

I-III**Queima mais fácil**

Pele que queima antes de bronzear. Fotoproteção rígida depois de qualquer técnica.

IV-VI**Mancha mais fácil**

Mais risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Prefira glicólico ou salicílico superficial; médio com muita cautela; fenol não é recomendado.

MA**Menos mancha**

O microagulhamento preserva a epiderme e mancha menos. A microdermoabrasão é descrita como segura em todos os fototipos.

CÁLCULO RESOLVIDO**Caso fictício: Ana, 34 anos, fototipo IV, oleosa, poros dilatados e manchas pós-acne**

Semana 0: avaliação, fotos, termo de consentimento e **priming de 3 semanas** (fotoprotetor e home care)

Semana 3: limpeza de pele, sem extrair lesão inflamada

Semana 5: peeling muito superficial, salicílico 20–30% (fototipo IV começa pelo mais leve)

Semana 8: 2º peeling, 3 semanas depois (diretriz: a cada 2–4 semanas)

Semana 11 e semana 15: microagulhamento 0,5 mm, 4 semanas de intervalo (faixa: 3–8 semanas)

Total: **5 sessões em 15 semanas**, reavaliação com fotos na semana 19

Cronograma ilustrativo montado pela ITH. As fontes não dão intervalo fixo entre técnicas diferentes: espere a pele se recuperar por completo e nunca some peeling e microagulhamento na mesma sessão sem indicação.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Checklist de cada sessão

Etapa	Conferir	Anotação
Anamnese	Fototipo, gestação, herpes, isotretinoína, anticoagulante, fotossensibilizante, quelóide	
Registro	Termo assinado, fotos, nº Anvisa do equipamento e lote dos produtos	
Biossegurança	EPI, antissepsia, material de uso único aberto na hora, coletor abaixo de 3/4	
Execução	Agente e %, tempo ou camadas; ou agulha (mm), passadas e ponto final	
Finalização	Neutralização, calmante, fotoprotetor, reação imediata	
Home care e retorno	Orientação por escrito, data da próxima sessão e intercorrências	

• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. O resumo das normas dos conselhos, a organização das etapas e o cronograma do caso fictício foram feitos pela ITH a partir delas.

- 01 **Anvisa: RDC nº 222/2018 (resíduos de serviços de saúde, arts. 2º, 86, 87 e 89) e RE nº 2.605/2006 (uso único)**
anvisalegis.datalegis.net · cff.org.br (íntegra da RDC 222)
- 02 **Anvisa: alerta sobre produtos estéticos usados de forma injetável (21/08/2023) e CCIH+ sobre a CP 1.423 (02/10/2026)**
gov.br/anvisa · ccih.med.br
- 03 **Lei nº 13.643/2018 (esteticista) e Lei nº 12.842/2013 (Ato Médico), art. 4º**
planalto.gov.br
- 04 **Cofen: Coren-RO sobre procedimentos autorizados (30/03/2026), Parecer 3/2026 e notícia do CFM (27/03/2025)**
coren-ro.org.br · cofen.gov.br · portal.cfm.org.br/noticias/132687
- 05 **CFBM: Res. 200/2011; TRF1 anula Res. 241/2014 (17/03/2026), nota da SBD (02/10/2026)**
cfbm.gov.br · trf1.jus.br · sbd.org.br
- 06 **COFFITO, Acórdão nº 293/2012 (fisioterapia dermatofuncional)**
crefito4.org.br
- 07 **CFE: STF mantém anulação da Res. 573/2013 (21/10/2024); TRF1 mantém Res. 669/2018 (27/10/2025)**
portal.cfm.org.br · site.cff.org.br
- 08 **Silva MCJ et al. Os benefícios da limpeza de pele no tratamento coadjuvante da acne vulgar. Rev Bras Mil Ciênc, 2020**
doi.org/10.36414/rbmc.v6i16.65
- 09 **Khunger N; IADVL. Standard guidelines of care for chemical peels. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2008**
ijdl.com
- 10 **Garellick E et al. Chemical peels in skin of color: a scoping review. Cureus, 2026**
[PMC13266789](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3266789/)
- 11 **Singh A, Yadav S. Microneedling: advances and widening horizons. Indian Dermatol Online J, 2016**
[PMC4976400](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24976400/)
- 12 **Springer A et al. Mechanically induced skin renewal. J Cosmet Dermatol, 2026**
[PMC13184425](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3184425/)
- 13 **StatPearls: Microdermabrasion e Laser Fitzpatrick Skin Type Recommendations (2023)**
[PMID 30571004](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571004/) · [PMID 32491558](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32491558/)
- 14 **Dermaplaning: revisão sistemática (2011), histologia (AAPS PharmSciTech, 2023) e Practical Dermatology (06/2024)**
[PMID 21533984](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21533984/) · [PMID 36725790](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36725790/)
- 15 **Isotretinoína e procedimentos: JAMA Dermatol 2017 e ASDS Task Force 2017**
[PMID 28658462](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28658462/) · [PMID 28498204](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28498204/)

Ressalvas. Competências mudam com decisões judiciais, e várias ainda cabem recurso: confirme no seu conselho regional. Concentrações e profundidades são as descritas na literatura, não autorizações. Avaliação individual, indicação do fabricante e prescrição médica prevalecem.

• PARA IR ALÉM

Quer dominar o protocolo com o paciente na sua frente?

Saber a teoria é o começo. Escolher a técnica certa para cada pele, ajustar a profundidade e lidar com a intercorrência se aprende com prática supervisionada.

Pós-graduação em Saúde Estética Avançada

- ✓ 5 vivências clínicas em pacientes modelo
- ✓ Mais de 30 técnicas faciais, corporais e capilares
- ✓ 600h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/estetica-captura/

Resumo em 30 segundos

3/4

é o limite para trocar o coletor de perfurocortantes

2–4 sem.

de priming antes do peeling químico

0,5 mm

é o limite do microagulhamento "cosmético" facial citado

3–8 sem.

de intervalo entre sessões de microagulhamento